

NPU19652 P-Amylase; kat.k.(IFCC 2006)



Metodeblad nr. M-016/14

Udarbejdet af: Anders Berg Wulff	Taget i brug: 12.08.2026	Revision: 12.08.2029
	Erstatter: 13.05.2026	

GENERELT	
Ansvarlig KBA analysesektion	Kemi
Indikation og resultatvurdering	Amylaser er enzymer, som katalyserer spaltning af polysakkerider, som f.eks. stivelse og glykogen. Amylaser findes i forskellige organspecifikke isoformer men dannes primært i spytkirtler og i pankreas (www.sundhed.dk). Benyttes til diagnosticering og monitorering af akut pankreatit samt kontrol af kronisk pankreatit. Desuden ved uspecifikke symptomer, der kunne være kræft. Ved kronisk nyresvigt samt makroamylasæmi kan der ses forhøjet P-Amylase. Makroamylasæmi skyldes komplekser af amylase og immuglobuliner, der ikke kan udskilles via nyrerne, hvorfor U-Amylase vil være normal.
Analysenavn og kode i SP	Amylase;P NPU19652
Analysenavn og kode i LABKA	P-Amylase NPU19652, AMYL
Analysenavn og kode i WebReq	Amylase;P NPU19652
Enhed	U/L
Prøvemateriale og rørtype	Plasma/serum. Vacurette® glas med grøn prop og sort ring, indeholdende Lithium-Heparin. Alternativt kan benyttes: Vacurette® glas med rød prop og sort ring uden tilsætning
Mindste prøvemængde	200 µL plasma. Svarende til ~400 µL fuldblod for voksne og børn og ~550 µL fuldblod for spædbørn. Der tages 50 µL plasma/serum fra prøven til en forfortynding. Fra denne forfortynding kræver analysen et volumen på 16 µL til en enkelt bestemmelse. Volumenet omfatter ikke dødvolumen i prøvebeholderen eller det supplerende volumen, som er nødvendigt ved udførelse af duplikater eller andre analyser på samme prøve.
Prøvetagning herunder særlige forhold	Ingen.
Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænser	0 døgn – 15 døgn: 3-10 U/L 15 døgn – 13 uger: 2-22 U/L 13 uger – 52 uger: 3-50 U/L 52 uger – 18 år: 25-101 U/L 18 år - 125 år: 25-120 U/L

NPU19652 P-Amylase; kat.k.(IFCC 2006)



Metodeblad nr. M-016/14

Ringe grænser	Ingen		
Udførende laboratorie	Herlev og Gentofte Klinisk Biokemisk Afdeling		
Analyseringshyppighed	Døgnet rundt, alle ugens dage.		
Svartid (efter modtagelse af prøve)	Svartid for 90% af analyserne er maksimalt 60 minutter. For praksisprøver svares samme dag.		
Prøvehåndtering	Intern rekvirent	Ekstern rekvirent	Praksis
	Ingen særlige forholdsregler		Opbevares i klimaskab indtil afhentning
Holdbarhed	Fuldblod: 4 døgn ved 20-25°C Afpipetteret materiale: 30 døgn ved 2-8°C		
Forsendelse	Intern transport	Region H's transportordning eller som farligt godt mærket "Biologisk stof kategori B"	Region H's transportordning ved 21 °C
Præanalytiske fejlkilder	Ingen særlige		
METODEBESKRIVELSE	<i>kun udfyldt for analyser udført af KBA HGH</i>		
CE mærket analyse (apparat og reagens i kombination)	Ja		
Akkrediteret analyse	Ja		
Metrologisk sporbarhed (rutinemålingens sporbarhed til referencemateriale og/el. -metode)	Atellica CH Amylase_2 analysen er sporbar til IFCC-reference-metoden og IFCC-456-referencemateriale.		
Analyseprincip	Fotometrisk måling af produkter dannet ved α -amylase og α -glucosidsase aktivitet.		
Apparatur	Siemens Atellica CH 930		
Kalibrator	Atellica CH SPLC CHEM CAL		
Reagens	Atellica CH Amylase_2 (AMY_2)		
Ekstern kvalitetskontrol	LABQUALITY3391 FI Almen klinisk biokemi		
Præcisionskontrolmaterialer (navn, producent, materialetype)	BIORAD Liquid Assayed Multiquel Level 1 serumbaseret	BIORAD Liquid Assayed Multiquel Level 3 serumbaseret	
Kontrolniveauer	47 U/L	314 U/L	
Intermediær præcision (CV _{oprundet} inkl. instru. spred.)	4,2%	2,5%	
Ekspanderet måleusikkerhed (k=2 sv.t. 95% CI på måleresultatet)	9,3%	6,4%	

NPU19652 P-Amylase; kat.k.(IFCC 2006)



Metodeblad nr. M-016/14

Mindste relevante kliniske difference	Ved to prøver på samme patient (målt med ovennævnte analysemetode) er den mindste klinisk signifikante forskel på de to svar 25,9 % beregnet på baggrund af en skønnet biologisk variation på 8,7 %
Måleområde (total) standard analysemåleområde måleområde fortynding (udstyr)	20-4500 U/L 20-1500 U/L 60-4500 U/L
Interferens <i>(hæmolyse, icterus, lipæmi, andet)</i>	Der ses ingen interferens (<10% bias) ved tilstedeværelse af: Hæmoglobin (0,34 mmol/L) Bilirubin (513 µmol/L konjugeret og ukonjugeret) Lipæmi (7,35 mmol/L)
Bemærkninger	Ingen

Dokumenthistorik

Dato		Initialer
13.05.2026	Planlagt revision. Mindste prøvemængde præciseret. Stillingtagen til fortsat klinisk relevans. Fortsat egnet.	AWUL0013
13.08.2026	Referenceinterval for børn <18 år ændres jvf harmoniseringsgruppebeslutning ref. 84.	AWUL0013